جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امال احمد عمر محمد
المحافظة : الفيوم **الحي / المدينة :** الفيوم **العنوان :** الغرقاوي
رقم البطاقة : 26407232301482 **رقم التليفون :** 01010062476 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 23-07-1964 **المهنة :** حلواني

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امال احمد عمر محمد
National ID: 26407232301482

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

ECHO REPORT

Name: آمال [illegible]

Date: 17/ 9 /2025

EF	66%	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	5.0	3.5-5.8cm	AO.R	2.9	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.7	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	1.0	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions — normal

LV wall thickness — normal

LV diastolic function — DD grade II

SWMA — no SWMA

LA and Ao root dimensions — normal

Mitral Valve — Trivial MR

Aortic valve — Mild AR

Tricuspid valve — Mild TR

Pulmonary valve — normal

Right side and systolic function — normal

Intracardiac masses and effusion —

Dr/ [illegible]

Echo
[[DOCTYPE:ECHO]]

Patient Name	: الأستاذه / امال احمد عمر محمد	Request No.	: 13009874
Patient No.	: 26407232301482	Request Date	: 17/09/2025
Path No.	: 2856/25	Verification Date	: 28/09/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 61 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: A case of right breast cancer (Post-NACT) underwent previous right BCS & SLNS with pathology report result showing positive metastatic deposits in two out of five sentinel lymph nodes with extra-nodal extension.
Nature of Specimen: Right completion axillary clearance.

Gross Examination:
- Fibrofatty tissue piece measured 11.5x6x1.5 cm, entangling 15 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5 cm.
- Sections prepared from paraffin blocks (3 & 4) for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for; CK7 (SP52).

Microscopic Examination:
- Histopathological examination reveals fifteen reactive hyperplastic lymph nodes with no evidence of metastatic deposits, L.Ns (0/15). Some of the lymph nodes showing therapy effect.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- Pan-ck (Done on blocks 3 &4): Negative in all examined lymph nodes.

Diagnosis:
Right completion axillary clearance:
- Fifteen lymph nodes negative for viable metastatic deposits, L.Ns (0/15).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.
Dr. Duaa Mohamed.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Amaal Ahmed Omar Mohamed	Date : 25/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 60 Year(s)
Medical ID: 3903/2024	Pat. ID: 94100

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Right malignancy

Report:

- ACR b: scattered fibroglandular parenchyma
- Right Breast:
  - Irregular dense mass is seen in the UOQ measuring 76 X 102 mm at CC view.
  - Ultrasound shows this mass as irregular heterogenous lobulated mass at 12 o'clock measuring 29 mm about 6 mm from the skin and 22 mm from the nipple.
  - Few less than three pathologically enlarged axillary lymph node are noted showing thick cortices and effaced hila (level 1)
  - No supra clavicular lymph node.
- Left Breast:
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Right breast malignant mass and level I axillary lymphadenopathy for histopathological assessment (BIRADS 6)
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Amaal Ahmed Omar Mohamed	Date : 10/11/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 60 Year(s)
Medical ID: 3903/2024	Pat. ID: 94100

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

known case of right breast cancer

I Chest:-

- Right breast asymmetrical density.
- Right axillary level I and II enlarged lymph nodes the largest one seen measuring 27mm.
- Right upper lung lobe anterior segment ground glass ill-defined nodule measuring 6 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definte enhancing focal lesions or contour irregularities
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:** no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- **Reported case of breast cancer**
- **No evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.**

dohaahmed

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

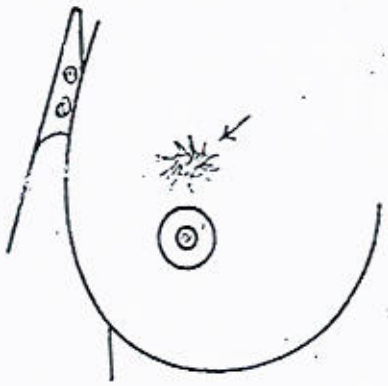
Elabd Scan Center

AMAL AHMED OMAR	10	September 30, 2024
PROF.DR./ MOHAMED NAGY		

Both breasts sonomammography

Right breast

- No retroareolar ductal ectasia.
- Mild fibroglandular breast parenchyma.
- **Irregular hypoechoic mass in the upper part of the right breast (12 o'clock) =15x17x19mm, with a thick echogenic halo around (Birad5).**
- No micro- or macro-calcifications.
- **Few pathological lymph nodes within the right axilla reaching up to ±23mm.**



Left breast

- No retroareolar ductal ectasia.
- Mild fibroglandular breast parenchyma with no discrete solid or cystic masses within.
- No micro- or macro-calcifications.
- Small chronic nonspecific lymph nodes within the left axilla reaching up to ±13mm

Conclusion

- ***Highly suspicious mass* (likely malignant) within the upper part of the right breast, with a few small pathological lymph nodes within the right axilla.**
- ***Tru-cut needle biopsies are recommended for further histopathological correlation.***

Dr./ Emad Halim Elabd

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جوستافروسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 6/10/2025 G

Name	آمال ا ع ء	MRN	CTE.VC٢٤٢٠١/٤٨٤
		ID	390324
Age	60/6	Phone	01010062476
Menopausal status	post	Marital status	
NRS SCORE		Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	postop CA
CO morbidity	HTN		Completion AC

Clinical Data BCS + ALND

BX: RT ILC

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	3/8	-ve	15%

R. Recieved NACT L



Initially T3 N1 TNM

Sonomammography:

Final pathology:

Mets Workup: RT Copeletion AC (0/15)

Previously SLN 2/5. c extra Nodal extension

Recommendations:

Recieved NACT

for possibility of adj. RT Omnia 5/10/2025

د. أميرة وفا

MDT OUTCOME & PLAN Post NACT ypT2 N2/5 SLNB → N2/10 RC

for ① PORT to Rt CW +PLN.

② Adjuvant ET (Upfront AI- Arimidex for 5yrs ⊕ Zometa q. 6 months).

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
6/10/2025					

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]